



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً :فايزة احمد اسماعيل السيد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : شبرا
رقم البطاقة : 28404150100665 رقم التليفون : 01008051473
العمر (تاريخ الميلاد) : 15-04-1984 المهنة : ربه منزل
العنوان :
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فائزة احمد اسماعيل السيد National ID: 28404150100665	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Age / Gender 32 Years - Female

Registered Date 2022-03-29 09:59 ص

Reporting Date 2022-04-18 10:14 ص

Visit No.

0-821

Patient Name

فايزة احمد اسماعيل السيد



PATHOLOGY REPORT

Specimen : 1. Right breast biopsy.
2. Right axillary lymph nodes.

Gross :

- I. Three greyish tan tissue cores ranging from 1cm to 1.5cm in length totally submitted as such in block no. (1).
- II. Multiple greyish white fragmented tissue cores measuring 0.6x0.6cm in aggregate, totally submitted as such in block no. (2).

Microscopic :

- I. Serial sections examined revealed three fibrofatty tissue cores show infiltration by sheets and nests of malignant ductal cells displaying moderate degree of pleomorphism hyperchromatism, occasional prominent nucleoli with high N/C ratio and occasional mitosis. The stroma is desmoplastic. TILs is minimal about 3%. No DCIS present. No perineural or lymphovascular invasion identified.

IMMUNOHISTOCHEMICAL RESULTS:

ER: Positive strong nuclear staining in 90% of neoplastic cells (Allred score 8/8).

PR: Faint positive immunostaining of few neoplastic cells (Allred score 3/8).

Her2-neu: Intense membranous immunostaining of neoplastic cells (3+).

Ki67: Positive nuclear immunostaining in 10% of neoplastic cells.

II. Serial sections examined revealed multiple fragments of fibrofatty tissue. one fragment is formed of aggregate of neoplastic cells with no nodal tissue identified.

Diagnosis :

- I. Tru cut biopsy from right breast mass:
Invasive breast (ductal) carcinoma, NST grade II. No insitu component.
- II. Tru cut biopsy from right axillary lymph node:
Positive for infiltration by the same malignant neoplasm confirmed by immunostaining.
No definite lymphoid tissue could be seen for further clinico radiologic correlation to assess the exact site of the provided biopsy

Hiba sayed

Signature

Prof. Ola Nada
Dr. Hiba Ahmed

Name: فايزة احمد اسماعيل السيد		
MR. : 3956		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها		
The patient is a 40-year-old premenopausal woman diagnosed with right breast invasive ductal carcinoma, grade 1, ER 8/8, PR 3/8, HER2 positive (3+). She received 18 weeks of neoadjuvant chemotherapy and targeted therapy (TCHP) starting 9/10/2022, followed by modified radical mastectomy (MRM) and post-mastectomy radiation therapy (PORT). Post-operatively she has been maintained on tamoxifen and Zoladex (goserelin) since that time. The patient has been taking tamoxifen 20 mg daily and Zoladex 10 mg subcutaneously once monthly, as documented in the pharmacy record for May 2026. The regimen has been continued without interruption. The patient reports a desire to discontinue therapy and pursue a conservative approach, noting she has only one child. She is currently scheduled to resume tamoxifen and Zoladex on 8/7. Transvaginal ultrasound shows an endometrial thickness of 7 mm with no vaginal bleeding. The current plan is to continue tamoxifen and Zoladex as prescribed, with monitoring of endometrial thickness and symptomatology.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	الطبيب المعالج : علياء احمد أبو النصر شهاب الدين	
يعتمد ,		

Ain Shams University Hospitals
Radiology department



مستشفيات جامعة عين شمس
قسم الأشعة التشخيصية

Patient Name: Faiza Ahmed Ismail Elsayed

Patient ID: OUT15567379

D/T: 5/9/2022 11:03:04 AM

MRI of Both BREASTS:

The study was performed on a 1.5 Tesla high field machine

Technique Ax & Sag DWI, T2, STIT, 3D GRE, T1WI Pre & post IV Gad & post processing subtraction, MIP & time intensity curves were generated & revealed

CLINICAL DATA: 38 years old female patient with right sided invasive duct carcinoma confirmed by biopsy

Findings:

- The right breast shows thickened skin.
- Right breast irregular speculated margin lesion (corresponding to one seen on ultrasound) seen retroareolarly measuring 22 x 20 mm. Other similar lesions are also seen involving the UOQs ranging from the the largest one seen at 9 o'clock spoition, 6.5 cm fro nipple measuring 20x15 mm to scattered subcnetimetri enhancing foci.
- Another area of clumped segmental non mass enehemencyt is seen at 8-9 o'clock spoition, 4 cm from nipple. This mesaures about 5x2 cm.
- These show low SI in both T1 and T2 WI with diffusion restriction with early arterial enhancement with no washout (type II plateau) curve
- Enlarged axillary lymph nodes , the largest one seen measuring 2.4 x 1.6 cm.
- Normal MRI of the left breast parenchyma, they display mix of fibroglandular tissue, fatty component with no detectable solid or cystic masses.
- No duct ectasia.
- No left sided pathologically enlarged LNs.
- Normal MRI of skin & subcutaneous tissue & nipple.

Conclusion:-

- Known case of right sided invasive ductal carcinoma with breast lesions as described above representing multicentric lesions with associated pathological lymph adenopathy

• Nada M. Farid, MSc

Dr?nermeen Nasry, MD

Ain Shams University Hospitals
Radiology department



مستشفيات جامعة عين شمس
قسم الأشعة التشخيصية

Patient Name: Faiza Ahmed Ismail Elsayed

Patient ID: OUT15567379

D/T: 3/24/2022 12:17:56 PM

SONOMAMMOGRAPHY OF BOTH BREASTS

Procedure: Digital mammography and real time ultrasonography of both breasts were performed.

Findings:

- Both breasts display normal skin thickness with normal appearance of the nipples and sub areolar regions.
- The breast parenchyma shows a predominantly glandular breast (ACR breast density **C**).
- Few scattered micro calcifications were detected in right breast.
- A solitary retro-areolar speculated lesion with a foci of calcification deposition
- Complementary US shows :
 - An irregular speculated hypoechoic lesion, is seen in the right breast , 12 - 1 o'clock position, 1 cm from the nipple measuring 1.8 x 1.5 cm and corresponds to the radiographic density seen on the mammographic film It shows no detected flow on Color Doppler
 - No suspicious solid or cystic masses were detected in the left breast
 - Enlarged right sided axillary nodes, some of which show increase cortical thickness reaching up to 6.5 mm with thinning out of their hilum.

Impression:

RIGHT BREAST LESION AS DESCRIBED ABOVE, HIGHLY SUSPICIOUS OF A MALIGNANT NATURE (BI-RADS 5) FOR HISTOPATHOLGY CORRELATION AND MRI CORRELATION

RIGHT SIDE AXILLARY SUSPICIOUS LOOKING LN FOR HISTOPATHOLGY CORRELATION

Much obliged

R . Mahmoud ELkordy
Nada Faried , MSc
Dr . Asmaa Magdy , MD
Ass. Prof . Merihan Nasr , MD



Patient Name: Faiza Ahmed Ismail Al Sayed	Date : 22/10/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 1806/2022	Pat. ID: 11069

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

Indication:

Patient is 40years old and is seen for follow-up after right MRM

Report:

- Right MRM:
 - Operative bed shows no mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Left Breast:
 - Heterogeneous fibroglandular parenchyma (ACR c)
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post right MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal sonomammography of left breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr Reem Mahmoud
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
22/10/2024 3:26 PM



Post-Op

مبادرة رئيس الجمهورية
لصحة المرأة المصرية

مبادرة
رئيس
الجمهورية
لصحة
المرأة
المصرية

MDT FORM 30 / 11 / 20 22 GA

Name	فايزة عبد الحليم	MRN	187
Age	58	ID	
Menopausal status		Phone	01001844
NRS SCORE		Marital status	Married
BMI		Family history	No
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX:				R L
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:	
Sonomammography:				
Immunohistochemistry:				



Recommendations: post. RT HRH
→ Free margins.
Free L.N 0/9

MDT OUTCOME & PLAN

Page 4/4 Hysterectomy 1 y - Post
N. Abdelrazek

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
[Signature]	[Signature]	[Signature]			